

Intervención nutricional y cambio de hábitos saludables

Análisis de casos clínicos: Manuel y Claudia

Trabajo de nutrición, educación alimentaria y promoción de la actividad física



Contenido del documento: valoración nutricional, cambios dietéticos, educación nutricional y plan de actividad física

Aprender a comer mejor, moverse más y consolidar hábitos saludables para mejorar la calidad de vida.

TRABAJO FINAL

PACIENTE 1:

Manuel es un señor de 65 años, soltero, jubilado desde los 57 debido a un infarto de miocardio. El médico de cabecera lo ha derivado a un dietista nutricionista por sus malos resultados bioquímicos en las dos últimas analíticas y por su aumento de peso en el último año. Siempre tiene tendencia a la obesidad, mide 170 cm y su peso actual es de 91,7 kg.

Desde el infarto, toma medicación para el hipercolesterolemia y la hipertensión, así como Sintrom (fármaco anticoagulante). En su última analítica de sangre le habían aumentado las cifras de colesterol LDL y disminuido las de HDL, por lo que fue necesario volver a ajustarle la medicación.

Nunca ha practicado ejercicio físico porque le parece una pérdida de tiempo. Aunque, obligado por la situación, desde hace un mes está yendo a andar 2 km por las tardes.

A continuación, se presenta lo que podría ser su ingesta de un día cualquiera de entre semana:

Hora	Lugar	Comida/Bebida
9:30 h		Café con leche entera y azúcar
11.15 h	Bar al lado de su casa	Pincho de tortilla de patata, una caña
14.15 h		Puré de verduras o ensalada o legumbres con chorizo, carne (costilla de cerdo, pollo o filete de ternera) con pimientos u otros vegetales, un café cortado con azúcar, dos vasos de vino tinto
19.30 h	Bar (con amigos)	Dos cañas, frutos secos o patatas
21.30 h		Bocadillo de queso curado o chorizo o jamón o tortilla de jamón, un vaso de vino

TRABAJO FINAL

1. Reseña de la situación nutricional y bioquímica

Manuel presenta una obesidad grado I (**IMC $\approx 31,7 \text{ kg/m}^2$**), con antecedente de infarto de miocardio, dislipemia mal **controlada** (**$\uparrow$ LDL, $\downarrow$ HDL**), hipertensión y tratamiento anticoagulante con Sintrom.

Tiene un patrón dietético es **hipercalórico**, rico en grasas saturadas, alcohol, azúcares simples y productos procesados, con baja presencia de fruta, verdura variada, pescado y cereales integrales.

Desde el punto de vista bioquímico y clínico, su alimentación y hábitos actuales favorecen:

- 👉 Empeoramiento del perfil lipídico.
- 👉 Aumento del riesgo cardiovascular.
- 👉 Incremento del peso y resistencia a la insulina.
- 👉 Interferencias potenciales con la medicación (alcohol y Sintrom).
- 👉 Riesgo de sarcopenia oculta por mala calidad proteica y escasa actividad física.

El paseo diario que lo obligan a hacer es un primer paso positivo, pero claramente insuficiente para compensar el resto del estilo de vida.

Si no modifica sus hábitos, tiene el riesgo de nuevo evento cardiovascular, descontrol del INR y progresión de la obesidad es elevado.

2. Cambios recomendados en alimentación y rutina

En la Alimentación se debería:

- ➡ Reducir de forma clara el Alcohol diario (idealmente eliminarlo o limitarlo a ocasiones puntuales).
- ➡ Reducir o eliminar preferentemente, embutidos, chorizo, queso curado y carnes grasas.
- ➡ Eliminar el Azúcar añadido (café, bebidas).
- ➡ Quitarse el hábito de Frituras y pinchos en bar.

TRABAJO FINAL

Se recomienda Aumentar el consumo de:

- Verduras y hortalizas en comida y cena.
- Fruta diaria (2–3 piezas).
- Pescado, especialmente azul, 2–3 veces/semana.
- Legumbres sin embutidos.
- Aceite de oliva virgen extra en cantidad moderada.

También debe cambiar lácteos enteros por semidesnatados o desnatados y ajustar raciones y horarios, evitando cenas tipo bocadillo graso.

Crear una Rutina:

- 👍 Debe mantener la caminata diaria y progresar pasando de 2 km a 30–45 min a paso ligero, introducir ejercicios de fuerza suave 2 días/semana (muy importante a su edad).
- 👍 Reducir el tiempo social ligado exclusivamente al alcohol (que el bar no sea el único plan social).
- 👍 Dormir y comer con horarios más regulares.

3. Ejemplo de menú completo para un día

Momento	Alimentos/Bebidas
Desayuno	Café con leche semidesnatada sin azúcar, tostada integral con tomate y aceite de oliva virgen extra, una pieza de fruta
Media mañana	Yogur natural desnatado o un puñado pequeño de frutos secos sin sal, agua
Comida	Lentejas estofadas con verduras (sin chorizo), filete de pescado al horno con verduras salteadas, pan integral (pequeña cantidad), fruta, agua (sin vino)
Merienda	Fruta o yogur natural, infusión o café sin azúcar
Cena	Ensalada completa con lechuga, tomate, zanahoria, huevo cocido y aceite de oliva, pechuga de pollo o pescado blanco a la plancha, pan integral pequeño, agua

TRABAJO FINAL

Resultado esperado si se sigue la pauta

-  Pérdida de peso gradual (0,5 kg/semana).
-  Mejora del LDL y aumento del HDL.
-  Mejor control de la tensión arterial.
-  INR más estable.
-  Menor riesgo de recaída cardiovascular.
-  Más energía y mejor calidad de vida.

4. Alimentación y Sintrom: qué debe saber Manuel

Debe saber que, con el Sintrom, el problema no es que tiene que consumir vitamina K, sino que tiene que hacerlo de forma más irregular.

Puntos clave para explicarle claramente:

Puede comer verduras de hoja verde (espinacas, acelgas, brócoli), pero siempre en cantidades similares semana a semana, debe evitar cambios bruscos en la dieta sin avisar al médico. El alcohol como interfiere con el control del INR, lo mejor es evitarlo y no debe tomar suplementos ni productos “naturales” sin consultar antes.

Tiene que evitar suplementos de:

-  Vitamina K.
-  Ginseng, ginkgo biloba, hierba de San Juan.

Controlar INR con mayor frecuencia si se modifican hábitos.

TRABAJO FINAL

PACIENTE 2:

Claudia es una adolescente de 15 años que acude a consulta derivada por su pediatra debido a un diagnóstico de sobrepeso y molestias digestivas (estreñimiento frecuente), además de dificultades para concentrarse y fatiga. Mide 1,68 m y pesa 79 kg (IMC $\approx$ 28).

Vive con sus padres, quienes trabajan fuera de casa todo el día, por lo que suele comer y cenar alimentos precocinados o rápidos de preparar. Su alimentación diaria se basa en alimentos ultraprocesados, azúcares simples y escaso consumo de fruta, verdura y fibra. No realiza ejercicio físico desde hace más de un año (antes asistía a clases de baile), y actualmente pasa más de cuatro horas al día frente a pantallas (ordenador, móvil, televisión).

No tiene ningún diagnóstico clínico adicional ni toma medicación actualmente, pero su pediatra considera que su alimentación y estilo de vida deben modificarse cuanto antes para evitar el desarrollo de enfermedades asociadas.

A continuación, lo que podría ser un ejemplo de un día típico de alimentación:

Hora	Comida/Bebida	Lugar
7.30 h	Zumo envasado	En casa
7.30 h	Pieza de bollería industrial	En el instituto
11.00 h	Snack tipo galletas o barrita de chocolate	En el instituto
14.30 h	Pasta con salsa de tomate frito	
14.30 h	Hamburguesa o salchichas	
14.30 h	Refresco azucarado	
17.00 h	Pan de molde blanco con crema de cacao	
17.00 h	Batido de chocolate	
21.30 h	Pizza precocinada o nuggets o sándwich con patatas fritas	
21.30 h	Refresco	

TRABAJO FINAL

Como hiciste con Manuel, haz una breve reseña sobre el estado nutricional de Claudia y los riesgos asociados a su alimentación actual.

Después, responde a estas preguntas:

- ¿Qué cambios debería introducir en su alimentación y estilo de vida para mejorar su salud?
- ¿Podrías proponer un ejemplo de menú diario adaptado a sus necesidades?
- ¿Qué estrategias de educación nutricional podrían aplicarse en su caso o entorno familiar?

CAMBIO DE ESTILO DE VIDA PARA MEJORAR LA SALUD

Cambios que debería introducir en su alimentación:

Claudia necesita reeducar su patrón alimentario, “**no ponerse a dieta**”.

Cambios prioritarios:

- ➔ No saltarse el desayuno, sustituyendo bollería y zumos por alimentos reales.
- ➔ Reducir ultraprocesados (pizza, nuggets, bollería, refrescos) a consumo ocasional.
- ➔ Eliminar bebidas azucaradas y priorizar agua.
- ➔ Aumentar el consumo de fibra:
 - ▣ Frutas (2–3 piezas/día).
 - ▣ Verduras en comida y cena.
 - ▣ Legumbres y cereales integrales.
- ➔ Sustituir harinas refinadas por integrales.
- ➔ Introducir proteínas de calidad: Pescado, huevos, legumbres, carnes magras.
- ➔ Establecer horarios regulares de comidas.
- ➔ Mejorar la calidad de las meriendas para evitar picos de hambre y fatiga.

TRABAJO FINAL

Estos cambios ayudarán a Claudia a:

- 👍 Mejorar el estreñimiento.
- 👍 Aumentar la saciedad.
- 👍 Mejorar energía y concentración.
- 👍 Favorecer la normalización del peso.

Ejemplo de menú diario adaptado a sus necesidades

Comida	Opciones recomendadas	Acompañamientos	Bebida
Desayuno	Leche semidesnatada o yogur natural, tostada integral con aceite de oliva y tomate o pavo	Pieza de fruta	
Media mañana (instituto)	Bocadillo pequeño integral de queso fresco o pavo, yogur natural con fruta		
Comida	Primer plato: lentejas con verduras o ensalada variada; Segundo plato: pollo a la plancha, pescado al horno o tortilla francesa	Guarnición de verdura cocida o salteada, pan integral moderado, fruta	Agua
Merienda	Pan integral con hummus o aguacate, yogur natural con fruta		
Cena	Crema de verduras o verduras salteadas, pescado, huevo o pechuga de pollo	Pan integral pequeño	Agua

Se recomienda el consumo ocasional de Refrescos, bollería y dulces, estos deben reservarse para ocasiones especiales, evitando su consumo diario para mantener una alimentación equilibrada y saludable.

Estrategias de educación nutricional en el caso de Claudia y su entorno familiar

Deberíamos explicar a Claudia, utilizando un lenguaje sencillo y directo, la importancia que tiene el consumo de fibra en la prevención y tratamiento del estreñimiento. Además, se debe destacar cómo una alimentación equilibrada influye positivamente en su energía diaria y en su capacidad de concentración para aspectos clave para su rendimiento académico y bienestar general.

Es importante evitar mensajes que puedan resultar de culpa, procurando en todo momento transmitir información de manera constructiva y motivadora. Para facilitar el cambio de hábitos, es recomendable establecer objetivos pequeños y fácilmente alcanzables, lo que permite a Claudia experimentar progresos sin sentirse abrumada. Asimismo, se debe fomentar su autonomía progresiva en la cocina, animándola a participar en la preparación de sus propios alimentos.

A nivel familiar

La implicación de los padres en la planificación semanal de menús es esencial. Es conveniente que en casa haya siempre alimentos saludables visibles y accesibles, facilitando así elecciones positivas en el día a día. También resulta útil preparar comidas sencillas con antelación, para garantizar opciones saludables y evitar recurrir a alternativas menos recomendables en momentos de prisa.

Mensaje clave: Enseñar a Claudia a realizar una lectura básica de las etiquetas de los productos puede ayudarle a tomar decisiones informadas. Además, proporcionarle ideas para meriendas saludables y rápidas facilitará que mantenga una alimentación equilibrada incluso en los momentos de mayor actividad. Es fundamental asociar la alimentación saludable con el bienestar y el autocuidado, evitando que se perciba como una restricción o prohibición.

TRABAJO FINAL

Mensaje clave final

“No se trata de hacer dieta, sino de aprender a comer mejor ahora para evitar problemas en el futuro”.

PLAN DE ACTIVIDADES FISICAS

Fase 1 · Activación: Pauta progresiva de actividad física para adolescentes

Objetivo

El principal objetivo de esta fase es que salga del sedentarismo sin generar rechazo hacia el ejercicio. Se busca que el movimiento se convierta en parte del día a día, priorizando la creación del hábito y el disfrute.

Frecuencia y duración

Se recomienda que realice actividad física entre 4 y 5 días a la semana, con sesiones de entre 20 y 30 minutos cada día. Esta frecuencia permite que el ejercicio se integre gradualmente en la rutina sin resultar abrumador.

Tipo de actividad

- 👉 Caminar a paso ligero.
- 👉 Bicicleta tranquila.
- 👉 Bailar en casa, especialmente recomendable en el caso de Claudia.
- 👉 Juegos activos como pasear al perro o patinar de forma suave.

Trabajo de fuerza

Incorporar ejercicios de fuerza dos días a la semana, dedicando aproximadamente 10 minutos por sesión. Los ejercicios sugeridos son:

- Sentadillas sin peso.
- Subir y bajar escaleras.
- Plancha corta, entre 10 y 20 segundos.

TRABAJO FINAL

- Ejercicios utilizando el propio peso corporal.

Gestión de tiempo frente a pantallas

debería realizar pausas activas cada 45–60 minutos cuando se está frente a una pantalla, para reducir el tiempo de sedentarismo y favorecer el movimiento regular.

Mensaje clave

“Moverse un poco todos los días es mejor que mucho un solo día”. Esta frase resume la importancia de la constancia y del hábito en la práctica de actividad física, promoviendo una vida más activa y saludable.

FASE 2 · CONSOLIDACIÓN (Semanas 5–8)

Objetivo:

El objetivo de esta fase es mejorar la resistencia física y la confianza en la práctica de actividad física regular.

Frecuencia y duración

Durante las semanas que abarca esta fase, es recomendable que realice actividad física cinco días a la semana, con sesiones que duren entre 30 y 45 minutos cada una. Ser regular es fundamental para consolidar los avances logrados y favorecer la creación de hábitos saludables.

Actividad aeróbica

- **Caminar rápido:** Ideal para mejorar la capacidad cardiovascular y mantener el cuerpo activo.
- **Bicicleta:** Es una opción que permite trabajar la resistencia mientras se disfruta del entorno.
- **Baile estructurado:** Puede optar por asistir a clases o seguir vídeos guiados, lo que aporta variedad y motivación.
- **Natación recreativa:** Además de ser una actividad completa, es suave para las articulaciones y adecuada para todos los niveles.

TRABAJO FINAL

Ejercicios de fuerza

Puede incorporar ejercicios de fuerza entre dos y tres días por semana, dedicando entre 15 y 20 minutos por sesión.

Estos son los ejercicios recomendados:

- **Sentadillas:** Fortalecen principalmente las piernas y glúteos.
- **Zancadas:** Permiten trabajar el equilibrio y la fuerza de las extremidades inferiores.
- **Flexiones apoyando rodillas:** Ideales para fortalecer el tren superior de manera progresiva.
- **Plancha** (20–30 segundos): Un ejercicio isométrico que activa el core y mejora la estabilidad.
- **Trabajo de core suave:** Ejercicios enfocados en la zona abdominal y lumbar, realizados de forma controlada.

Estiramientos

Al finalizar cada sesión, es importante dedicar entre cinco y diez minutos a los estiramientos. Esto favorece la recuperación muscular y ayuda a prevenir lesiones.

Mensaje clave

“No es competir, es progresar”. Se subraya la importancia de centrarse en la mejora personal y el avance gradual, en lugar de la comparación con los demás.

FASE 3 · AUTONOMÍA Y HÁBITO (Semanas 9-12)

Durante la tercera fase, el objetivo principal es lograr que el ejercicio físico pase a formar parte de la identidad de Claudia, consolidando el hábito y promoviendo la autonomía en la práctica deportiva.

Frecuencia semanal

Es recomendable realizar ejercicio entre cinco y seis días a la semana, lo que permite mantener una rutina constante y favorecer la integración del deporte en el día a día.

Las sesiones deben tener una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos. Este tiempo es suficiente para obtener beneficios tanto

TRABAJO FINAL

físicos como mentales, y facilita la adaptación progresiva de la persona al ejercicio regular.

Distribución de actividades

- 👉 **3 días** de actividad aeróbica, como baile, caminar rápido o montar en bicicleta. Con estas actividades se mejoran la capacidad cardiovascular y la resistencia general.
- 👉 **2 días** de ejercicios de fuerza combinados con trabajo de core. Con este tipo de entrenamiento se ayuda a fortalecer la musculatura y a mejorar la estabilidad corporal.
- 👉 **1 día** de actividad libre, que puede realizarse con amigas o practicando cualquier deporte recreativo. El objetivo es disfrutar del movimiento y socializar a través del ejercicio.

Como recomendación principal, Se aconseja volver a las clases de baile si es posible, ya que el baile combina ejercicio aeróbico con diversión y permite reforzar el hábito de manera amena.

Mensaje clave

“El mejor ejercicio es el que quieres repetir”. Con esta frase se resume la importancia de elegir actividades que resulten motivadoras y satisfactorias, para asegurar la continuidad y el disfrute en la práctica deportiva.

X

RAMON ALBERTO CURBALAN VEGA
TECNICO ACTIVIDADES FISICAS